

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Alberto Mejía Sánchez

DOCUMENTO

CC 19234567

FECHA NACIMIENTO

05/09/1953

EDAD

72 años, 9 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

Profesional (Ingeniería)

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

18/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001248

PROTOCOLO APLICADO

Neuronorma Colombia AM + GDS-15 + BDI-II

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Alberto Mejía Sánchez	Lateralidad:	Diestro
Documento:	CC 19234567	Ocupación:	Pensionado (empresario)
Fecha de nacimiento:	05/09/1953	Ciudad:	Medellín, Antioquia
Edad:	72 años, 9 meses	Acompañante:	Lucía Mejía de Restrepo
Sexo:	Masculino	Remite:	Neurólogo
Escolaridad:	Profesional (Ingeniería)	EPS / Asegurador:	Sura EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Quejas subjetivas de memoria de 2 años de evolución. Olvidos de citas, repetición de preguntas, dificultad para encontrar palabras. Funcionalidad global preservada. Antecedente de HTA.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: Neuronorma Colombia AM + GDS-15 + BDI-II

Prueba	Dominio	Dur.
TMT A	Atención	—
TMT B	Funciones Ejecutivas	—
Span Retención Dígitos Directo	Memoria de Trabajo	—
Span Retención Dígitos Inverso	Memoria de Trabajo	—
Test de Stroop Palabra	Atención	—
Test de Stroop Color	Atención	—
Test de Stroop Palabra/Color	Atención	—
Fluidez Verbal Animales	Lenguaje - Fluidez	—
Fluidez Verbal Fonémica (P)	Lenguaje	—
ViDeno	Lenguaje	—
Grober RL Ensayo 1 (libre)	General	—
Grober RLT - Retención Libre Total (E1)	General	—
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+)	General	—
Escala de Depresión Geriátrica Yesavag	Socioemocional - Depresión	—
Escala de Lawton y Brody (IADL)	General	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Antecedente de trastorno depresivo en tratamiento con sertralina 50 mg/día.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Niega TEC.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Atención y concentración

Atención sostenida preservada. Atención selectiva en límite inferior.

Memoria

Déficit en memoria episódica anterógrada con curva de aprendizaje aplanada. Reconocimiento descendido. Sugestivo de perfil amnésico.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

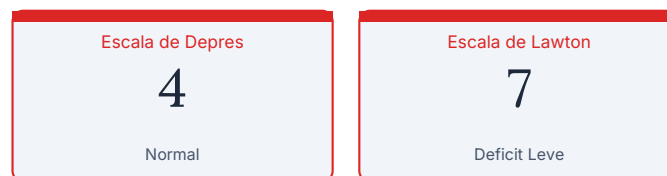
Anomia leve. Fluidez fonémica y semántica descendidas. Comprensión preservada.

Cociente intelectual (observación)

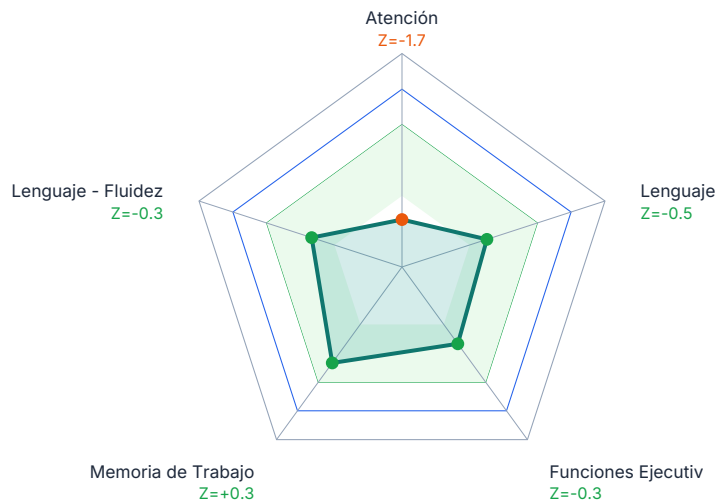
Perfil cognitivo global: F06.7 - Deterioro cognitivo leve (DCL)

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo

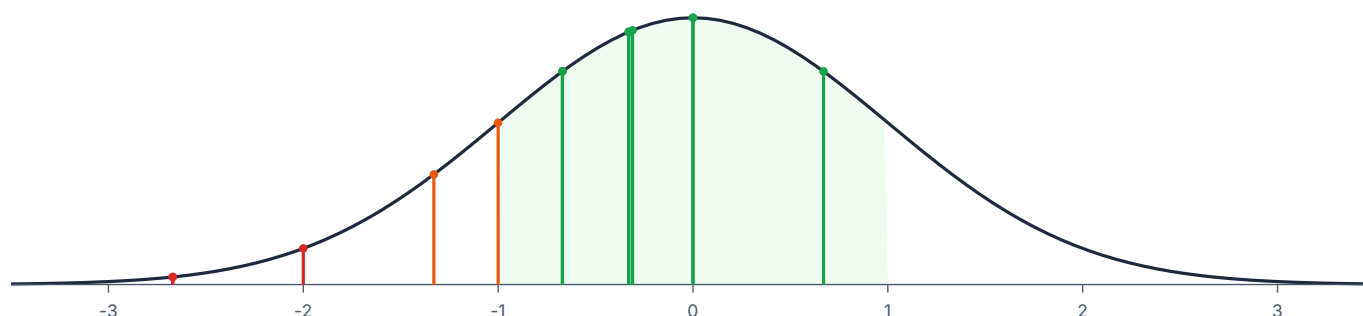


Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 13 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
TMT A							-0.67
TMT B							-0.33
Span Retención Dígitos Directo							+0.67
Span Retención Dígitos Inverso							+0.00
Test de Stroop Palabra							-2.00
Test de Stroop Color							-2.67
Test de Stroop Palabra/Color							-1.33
Fluidez Verbal Animales							-0.33
Fluidez Verbal Fonémica (P)							-0.67
ViDeno							-0.31
Grober RL Ensayo 1 (libre)							-2.67
Grober RLT - Retención Libre Tot							+0.00
Grober RT - Recuerdo Total Clave							-1.00
Escala de Depresión Geriátrica Y							-6.40
Escala de Lawton y Brody (IADL)							-6.20

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z < -1 sugiere debilidad. Z > +1 sugiere fortaleza relativa.

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
TMT A	110	8	-0.67	Promedio
TMT B	195	9	-0.33	Promedio
Span Retención Dígitos Directo	5	12	+0.67	Promedio
Span Retención Dígitos Inverso	3	10	+0.00	Promedio
Test de Stroop Palabra	38	4	-2.00	Bajo
Test de Stroop Color	30	2	-2.67	Bajo
Test de Stroop Palabra/Color	12	6	-1.33	Límitrofe
Fluidez Verbal Animales	12	9	-0.33	Promedio
Fluidez Verbal Fonémica (P)	9	8	-0.67	Promedio
ViDeno	38	38	-0.31	Promedio
Grober RL Ensayo 1 (libre)	6	2	-2.67	Bajo
Grober RLT - Retención Libre Total	8	10	+0.00	Promedio
Grober RT - Recuerdo Total Claves	12	7	-1.00	Promedio
Escala de Depresión Geriátrica Yes	4	4	-6.40	Normal
Escala de Lawton y Brody (IADL)	7	7	-6.20	Deficit Leve

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: atención (moderadamente disminuido, $Z=-1.7$); general (moderadamente disminuido, $Z=-1.2$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Test de Stroop Color ($Z=-2.67$, bajo); Grober RL Ensayo 1 (libre) ($Z=-2.67$, bajo); Test de Stroop Palabra ($Z=-2.00$, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Grober RL Ensayo 1 (libre) — bajo ($Z=-2.67$)
- Test de Stroop Color — bajo ($Z=-2.67$)
- Test de Stroop Palabra — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Palabra/Color — límite ($Z=-1.33$)
- Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3) — promedio ($Z=-1.00$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Alberto. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En ViTMTA, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En ViTMTB, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En ViRDD, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En ViStP, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En ViStC, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En ViGroberRLT, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En ViTMTA, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViTMTB, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViRDD, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViRDInv, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViAni, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViStP, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViStC, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViGroberRLT, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

- ¿Mis resultados son permanentes?
No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.
- ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?
Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.
- ¿Necesito otro tipo de evaluaciones?
Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.